适用范围与诊断标准

面向眼科门诊与病房的速查摘录，不引入原文以外的诊疗阈值

临床识别〔2023 p14〕

多为单眼发病，常见眼红、畏光、视物模糊、眼痛。
体征：角膜基质水肿、水肿区 KP 、后弹力层皱褶，可伴前房轻度炎症、虹膜改变、眼压升高。

按原文诊断标准〔2023 p15〕

临床诊断：符合依据 1 （急性起病，感染史 / 诱因可有）和 3 （临床体征）。
病因诊断：符合依据 1 、 3 和 4 或 5 。
4： IVCM 辅助检查；猫头鹰眼对应 CMV 。
5： PCR 检查病毒阳性。

注意：依据 1 中的感染病史或免疫下降诱因写作“可存在／可能存在”，不能改为人人必须具备。〔2023 p15〕

年龄适用边界、独立“疑似／确诊”分级、正式推荐等级：原文未明确。〔2023 p13–19〕

来源：中国病毒性角膜内皮炎诊疗专家共识（2023）｜ p 为期刊页码， PDF 页码 =p−12

分型、风险线索与鉴别

原文没有正式危险评分或住院／转诊切点；下列为临床描述

临床分型〔2023 p15〕	重点特征与风险〔2023 p15〕
盘状	最常见；界限清晰的盘状基质水肿，水肿区大量羊脂状 KP
弥漫性	弥漫水肿与弥散 KP ；严重水肿时 KP 可看不清
线状	最严重；进展性线状 KP ，内皮细胞丢失最快，易失代偿
扇形	扇形水肿、相应区散在 KP ；界限清晰，无进展性线状 KP

重点鉴别〔2023 p15–16〕

前葡萄膜炎、角膜基质炎、内皮失代偿、 Fuchs 、 Chandler 、移植后排斥、急闭发作。
移植排斥线多在植片内；病毒性 KP 可跨植片与植床交界。

急闭“ 50~60 mmHg” 仅是鉴别描述，不能当作本病降眼压启动阈值。〔2023 p16〕

辅助检查与病原线索

病原线索服务于检查与鉴别，不能替代原文诊断标准

检查与解释〔2023 p14–15〕

IVCM：观察内皮形态、计数，监测细胞密度变化与预后。
房水 PCR：可明确病毒；缓解期阳性率不高，阴性不能排除感染。
必要时补充房水特异抗体与 G-W 系数； IgM 提示近期、 IgG 提示远期感染。

病原	提示性表现〔2023 p15〕
CMV	线状 / 扇形、钱币样 KP 、常眼压高； IVCM 猫头鹰眼
HSV	多盘状，也可弥漫；基质水肿、虹膜炎，可有感染史
VZV	四型均可；皮损可有可无；虹膜萎缩、瞳孔变形

PCR 病毒载量／ Ct 、 G-W 系数切点、内皮细胞密度切点、重复采样时间：原文未明确。〔2023 p13–19〕

一页诊疗流程

条件与下一步均按 2023 共识；独立 A4 流程图含完整监测阈值

1 依据 1： 急性起病，感染史 / 诱因可有；依据 3： 基质水肿 /KP/ 后弹力层皱褶
符合 1 和 3 → 临床诊断；不符合 → 核对鉴别〔 2023 p15–16 〕

↓

2 IVCM + 房水 PCR ；必要时特异抗体／ G-W
按依据 1 、 3 和 4 或 5 作病因诊断； PCR 阴性不能排除〔 2023 p14–15 〕

↓

3 按病原抗病毒〔 2023 p16–17 〕
HSV： 阿昔洛韦 / 更昔洛韦 CMV： 更昔洛韦 VZV： 更昔洛韦 / 泛昔洛韦等

↓

4 在有效抗病毒基础上联合眼部激素；眼压升高则降压
严重内皮失代偿 → 移植及围术期抗病毒〔 2023 p17 〕

治疗前及治疗中
更昔洛韦监测〔 2023 p16 〕

停药条件
肝肾功能恶化
血小板≤ 25×10^9/L
粒细胞≤ 0.5×10^9/L
或降至用药前 50%

3 周无效 → 考虑耐药，改膦甲酸钠。

复诊间隔、眼压干预阈值：原文未明确。

来源：中国病毒性角膜内皮炎诊疗专家共识（ 2023 ）｜ p 为期刊页码， PDF 页码 =p−12

按病原选择抗病毒与局部用药

所有药物方案为共识原文摘录；不要补入原文未给的剂量

病原	原文治疗方向〔2023 p16–17〕
HSV	全身与眼部阿昔洛韦或更昔洛韦为主
CMV	全身与眼部首选更昔洛韦；易复发者适当延长治疗；阿昔洛韦无效
VZV	全身更昔洛韦／泛昔洛韦或更高剂量阿昔洛韦；局部更昔洛韦 “更高剂量”的确切数值：原文未明确

局部更昔洛韦〔2023 p16〕

0.15% 眼用凝胶或 0.1% 滴眼液：治疗 4~6 次 /d 。
病变痊愈后： 2 次 /d ，巩固 2~4 周。

单篇研究转述，单独标注

共识引述 [36]： 2% 更昔洛韦滴眼液研究为 CMV 前葡萄膜炎。原文称国内尚无高浓度成品；不提供配制方案或频次。〔2023 p16 ； 文献 p19〕

注意：不能把 0.15% ／ 0.1% 制剂的 4~6 次 /d 自动套用到 2% 制剂。

成人全身抗病毒剂量

逐项摘录 2023 共识 p16；不以其他指南或药品说明书的方案替换原文

药物	治疗／诱导方案〔2023 p16〕	后续方案／限制〔2023 p16〕
阿昔洛韦	200 mg/ 次， 5 次 /d ，共 7 d	缓解后 400 mg/d ，共 4~6 个月 原文称“减少至诱导剂量”
伐昔洛韦	500 mg/ 次， 2 次 /d ，共 7 d	其他维持方案：原文未明确
更昔洛韦	口服 1 g/ 次， 3 次 /d ，共 14 d 或慢速静滴 250 mg/ 次， 1 次 /12 h ，共 14 d	维持：口服 0.5 g/ 次， 3 次 /d ，共 2 个月
泛昔洛韦	口服 0.25 g/ 次， 3 次 /d ，共 7 d	肾功能不全按肾功能调整；具体分档原文未明确
膦甲酸钠	耐药疱疹二线，需静脉给药	可严重肾毒性，需充分水化；剂量／疗程原文未明确

阿昔洛韦： CMV 无效；肾功能损伤应避免，静滴过快增加肾损伤风险。
阿昔洛韦“ 400 mg/d” 为每日总量，不能改成 400 mg/ 次。〔2023 p16〕

来源：中国病毒性角膜内皮炎诊疗专家共识（2023）｜ p 为期刊页码， PDF 页码 =p−12

药物监测、停药阈值与儿童

更昔洛韦长期用药存在骨髓抑制及肝肾不良反应〔2023 p16〕

更昔洛韦实验室监测〔2023 p16〕

用前：血常规、肝肾功能。
诱导期：血常规每隔 3 d，肝肾每周。
维持期：血常规每周，肝肾每 2~4 周。
停药：肝肾恶化；血小板≤ 25×10^9/L；粒细胞≤ 0.5×10^9/L 或降至用前 50%。
治疗 3 周无效：考虑耐药，改膦甲酸钠。
骨髓移植患者慎用。

儿童方案〔2023 p16〕

阿昔洛韦诱导：
每千克体重 10~15 mg/d，共 7 d，分 3~5 次给药。

更昔洛韦：每千克体重 5 mg/ 次。
诱导 2 次 /d，共 14 d。
维持 1 次 /d，共 2 个月。
儿童给药途径：原文未明确。

妊娠／哺乳专用方案、儿童年龄分档与最大剂量、肾功能调整表、肝肾恶化数值界值：原文未明确。〔2023 p13–19〕

激素、眼压、手术与随访

共识建议与原文缺项分开，避免把常识补写成共识规定

激素递减〔2023 p17〕

前提：在有效抗病毒基础上联合眼部激素。
1% 醋酸泼尼松龙或妥布霉素地塞米松滴眼液 4 次 /d ；必要时夜用后者眼膏。
羊脂状／尘状 KP 消退后，每周减少 1 次，至 1 次 /d 后按炎症决定低浓度制剂（氯替泼诺、 0.1% 氟米龙）。
用药中关注眼压。

眼压与移植〔2023 p17〕

眼压升高需降压；恢复正常后减停。
慎用前列腺素类，关注各药禁忌。
严重内皮失代偿需角膜／内皮移植；术前后充分抗病毒。
术后全身抗病毒通常 3~6 个月，定期血常规及肝肾复查。

随访： KP ／炎症、眼压、 IVCM 内皮变化；化验频次见第 7 页。避免劳累、感冒，加强锻炼。〔2023 p14 、 16–17〕

统一眼科复诊间隔、目标眼压、完整禁忌清单及推荐等级：原文未明确。〔2023 p13–19〕

来源：中国病毒性角膜内皮炎诊疗专家共识（2023）｜ p 为期刊页码， PDF 页码 =p−12